

- 抗癌剤の中では、マイトマイシン C やシクロスポリンも報告が多い。
- 抗てんかん薬の中では、カルバマゼピンも報告が多い。
- × ワルファリンと併用することで、ワルファリン濃度を上昇させ出血のリスクが高くなる。しかし、単独投与では肺胞出血のリスクは低い。
- 抗不整脈薬の中では、硫酸キニジンも報告が多い。

○ 肺胞出血や急速進行性糸球体腎炎を引き起こす Goodpasture 症候群で検出される。

○

× 副腎皮質ステロイド、免疫抑制剤（シクロホスファミド）、血漿交換療法の併用が推奨されている。

×

急速進行性糸球体腎炎の中で最も腎予後が悪い。

13

○ 中心部の壊死を柵状に組織球と巨細胞が取り囲む所見である。多発血管炎性肉芽腫症の肺病変の病理所見としては、地図状壊死や多核巨細胞を伴う肉芽腫性病変などもみられる。

○ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症では約 50～70% が MPO-ANCA 陽性である。一方、PR3-ANCA 陽性の血管炎のほとんどは多発血管炎性肉芽腫症であり、特異度が高い。

○ 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症と難治性喘息でメボリスマブの用量が異なる。好酸球性多発血管炎性肉芽腫症：1 回 300 mg を 4 週間ごと皮下注射。難治性喘息：1 回 100 mg を 4 週間ごと皮下注射。